

# PDF ANONIMIZADO

ID publico: case\_0302

Paginas del documento: 14

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

---

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

, arranjo familiar e autoavaliação de saúde. Os dados encontrados mostram que os participantes do Projeto de extensão UNAMI/UEMS possuem alta resiliência, fato este que destaca a importância de políticas públicas voltadas à promoção da saúde.

**Palavras-chave:** Resiliência Psicológica. Idoso. Envelhecimento. Saúde do Idoso. Educação em Saúde.

## ABSTRACT

**Introduction:** Population aging requires understanding the factors that promote quality of life in old age, such as resilience, the individual's intrinsic ability to adapt to stressful or traumatic situations, preserving their health and emotional stability. **Objective:** To describe the health and resilience characteristics of elderly participants in the Open University of the Elderly (UNAMI) of the State University of Mato Grosso do Sul (UEMS). **Method:** A quantitative cross-sectional study was conducted with 20 elderly individuals participating in UNAMI/UEMS in Dourados, Mato Grosso do Sul, Brazil. The Resilience Scale adapted by Pesce *et al.* (2005) was used, consisting of 25 questions grouped into three factors: Factor 1. Resolution of actions and values that give meaning to life; Factor 2. Groups items that convey the idea of independence and determination; and Factor 3. Indicates self-confidence and the ability to adapt to situations. The data were analyzed using descriptive and analytical statistics. **Results:** In the sample studied, there was a predominance of women (85%), white people (65%), those who did not live alone (60%), retired or pensioned people (80%). The average resilience was high (157.05), with 75% of participants evaluating their health as "good/very good" and there was no statistical significance between the levels of the resilience scale and the variables sex, skin color, family arrangement and self-assessment of health. **Conclusion:** The data found in the study indicate that the participants of the UNAMI/UEMS extension project have high resilience, a fact that highlights the importance of public policies aimed at promoting healthy aging.

**Keywords:** Resilience, Psychological. Aged. Aging. Health of the Elderly. Health Education.

## RESUMEN

**Introducción:** El envejecimiento poblacional requiere comprender los factores que promueven la calidad de vida en la vejez, como la resiliencia, la capacidad intrínseca del individuo para adaptarse a situaciones estresantes o traumáticas, preservando su salud y estabilidad emocional. **Objetivo:** Describir las características de salud y resiliencia de las personas mayores participantes de la Universidad Abierta para las Personas Mayores (UNAMI) de la Universidad Estatal de Mato Grosso do Sul (UEMS). **Método:** Estudio cuantitativo transversal, realizado con 20 ancianos participantes de la UNAMI/UEMS, en Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Se utilizó la Escala de Resiliencia adaptada por Pesce *et al.* (2005), compuesto por 25 preguntas agrupadas en tres factores: Factor 1. Resolución de acciones y valores que dan sentido a la vida; Factor 2. Agrupa elementos que transmiten la idea de independencia y determinación; y Factor 3. Indica confianza en uno mismo y capacidad de adaptación a las situaciones. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva y analítica. **Resultados:** En la muestra estudiada predominó el sexo femenino (85%), personas de raza blanca (65%), personas que no vivían solas (60%), personas jubiladas o pensionadas (80%). La resiliencia promedio fue alta (157,05), con un 75% de los participantes evaluando su salud como "buena/muy buena" y no hubo significancia estadística entre los niveles de la escala de resiliencia y las variables sexo, color de piel, arreglo familiar y salud autoevaluada. **Conclusión:** Los datos encontrados en el estudio muestran que los participantes del proyecto de extensión UNAMI/UEMS presentan una alta resiliencia, hecho que resalta la importancia de las políticas públicas orientadas a la promoción del envejecimiento saludable.

## ÃO

O termo resiliência surge em textos da Psicologia salientando a vontade dos investigadores em compreender a possibilidade do desenvolvimento adaptativo poder ocorrer em ambientes de adversidade. Em termos gerais, a resiliência refere-se “à adaptação positiva manifestada em face de experiências negativas” (Masten; Gewirtz, 2008, p. 22), sendo conceituada como a capacidade intrínseca do indivíduo de se adaptar a situações de estresse ou trauma, preservando sua saúde e estabilidade emocional (Sivri; Ünal; Güleç, 2019). Tal conceito está articulado a um contexto de cinco dimensões que incluem a autossuficiência, o sentido da vida, a equanimidade, a perseverança e a singularidade existencial. Além disso, a resiliência é uma característica da personalidade humana que atua como um moderador eficaz dos efeitos negativos das mais diversas circunstâncias (Ercan, 2017).

Estudos apontam que os fatores de proteção são elementos considerados indispensáveis quando se trata de resiliência e contribuem para minimizar efeitos negativos ou disfuncionais em eventos que expõem o sujeito a situações de risco, podendo modificar a sua resposta pessoal em circunstâncias adversas (Souza; Pinto; Araújo, 2017; Jones-Bitton *et al.*, 2020).

A resiliência está frequentemente associada a fatores de proteção pessoal que predizem resultados positivos para indivíduos expostos a ambientes de risco. Assim, pesquisas sobre o tema da resiliência como fator de proteção que auxiliará no impacto das atividades básicas da vida diária, na autoestima e no bem-estar subjetivo, particularmente em idosos institucionalizados, se justificam (César, 2016).

Enquanto a Psicologia tradicional, representada por correntes como o behaviorismo radical de Skinner e os modelos biomédicos de Kraepelin, centra-se na identificação de patologias e déficits, as teorias contemporâneas – como a Teoria da Resiliência (Masten; Gewirtz, 2008) e a Teoria da Psicologia Positiva (Seligman, 2019) – destacam a capacidade humana de adaptação positiva. Essas abordagens reconhecem que a resiliência emerge da interação entre recursos internos, redes sociais, acesso a saúde, capital e políticas públicas, transcendendo a visão reducionista de vulnerabilidade (Seligman, 2011).

No cenário brasileiro, pesquisas como as desenvolvidas por Fontes e Neri (2019) demonstram que estratégias de enfrentamento mediadas por suporte social são determinantes para a resiliência em idosos, particularmente em populações socioeconomicamente vulneráveis. Seus estudos evidenciaram que a participação em grupos comunitários e redes de apoio formal potencializam a capacidade adaptativa na velhice, corroborando a premissa de que os mecanismos resilientes são socialmente construídos (Silva *et al.*, 2019). É uma perspectiva que ecoa o princípio de que a resiliência não é um traço individual fixo, mas moldado por sistemas mais amplos, como os sistemas sociais, reforçando a necessidade de políticas públicas contextualizadas (Estêvão; Calado; Capucha, 2017).

Os idosos devem estar preparados para enfrentar desafios e dificuldades que possam surgir e manter a capacidade de adaptação para melhor se adaptarem a esta fase da vida. O estado de bem-estar é influenciado por fatores que envolvem dimensões emocionais, sociais, culturais e físicas que decorrem das condições objetivas e subjetivas que constituem áreas da vida, como trabalho, vida social, saúde física e emoções. Além disso, pode estar

ado de vitalidade, mas também como se sente durante as atividades básicas já no âmbito físico, psicológico ou social (César, 2016).

transcende um conjunto de estratégias de reação e funciona como uma ponte teórica estabelecida entre os processos reativos e o desenvolvimento (Leipold; Greve, 2009). Caracteriza-se como uma combinação de respostas individuais perante certas situações e diferentes contextos sociais (Fontes; Neri, 2019).

Deste modo, destaca-se que a resiliência pode variar conforme os cenários e a quantidade e combinação de estressores, de modo que um indivíduo pode ser mais resiliente em uma situação e menos resiliente perante outras (Oliveira *et al.*, 2023).

A adaptação positiva aos estressores concede maior domínio para lidar com o estresse, e, ao passar do tempo, capacidade de lidar e superar situações adversas (Fontes; Neri, 2019).

A autoavaliação do estado de saúde é um indicador recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para verificar a saúde das populações (Pagotto; Bachion; Silveira, 2013). Caracteriza-se como um dos principais componentes da resiliência psicológica, levando-se em consideração que uma melhor avaliação psicológica se dá em decorrência da aplicação de estratégias de enfrentamento, voltadas ao desenvolvimento e adaptação mediante cenários variados. A avaliação de saúde negativa tem seu maior índice entre indivíduos que utilizam estratégias não adaptativas, já a avaliação positiva apresenta-se entre aqueles que

com menor escolaridade, renda mais baixa e menos privilégios sociais, têm maior probabilidade de avaliar negativamente sua saúde. E a autoavaliação da saúde, é influenciada por variáveis individuais e pelos ambientes micro, meso e macro (Sousa *et al.*, 2020).

A adaptação psicossocial em idosos está intrinsecamente interligada com a forma como lidam com eventos impactantes relacionados a alterações de saúde, limitação funcional, perda de familiares, e todos esses fatores podem impactar na saúde mental e física dos idosos, afetando sua autoavaliação de saúde (Lima *et al.*, 2018).

Em idosos hospitalizados, avaliar indicadores de estresse, ansiedade e depressão e investigar suas percepções sobre si e sobre o processo de envelhecimento é de extrema importância, pois permite subsidiar a reflexão, a discussão e a ação de profissionais de saúde, estudantes e gestores para a mudança de atitudes. Assim, torna-se crucial implementar políticas públicas de cuidados gerontológicos que visem mudar as atitudes em relação ao cuidado dos pacientes idosos e remover o estigma do envelhecimento (Freire; Dias, 2021).

ato Grosso do Sul (UNAMI/UEMS).

## METODOLOGIA

Foi desenvolvida pesquisa de corte transversal com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado na UNAMI/UEMS, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul (MS), Brasil.

A UNAMI/UEMS iniciou suas atividades em 2014 com o intuito de resgatar a autoestima dos idosos, oferecendo oportunidades para que eles se sintam produtivos, úteis, ativos e agentes atuantes na comunidade à qual pertencem. O programa contribui, principalmente, para o resgate da cidadania e do espaço político desses indivíduos (Medeiros *et al.*, 2020).

Em 2023, houve a inscrição de 30 idosos no projeto. A coleta de dados ocorreu em dois dias, no mês de agosto daquele ano (nas duas últimas quartas-feiras do mês). O critério de inclusão foi frequentar as atividades presenciais no segundo semestre. Nos dois dias de coleta participaram, no total, 20 pessoas; sendo assim, foi estabelecida a técnica de amostragem por conveniência (Hoga; Borges, 2016). A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista individual com os idosos, norteadas por um questionário contendo questões fechadas. As entrevistas foram realizadas por estudantes bolsistas de iniciação científica e de extensão, os quais foram capacitados pelos docentes responsáveis pela pesquisa.

A avaliação sociodemográfica utilizou as variáveis: sexo (feminino; masculino), idade (em anos), estado civil (solteiro; casado; viúvo; divorciado/separado), escolaridade (em anos completos de estudo), cor da pele (autorreferida como branca, parda, preta e amarela), arranjo familiar (se reside sozinho ou acompanhado) e ocupação atual (ativo/trabalha; inativo/aposentado ou pensionista). Para a autoavaliação de saúde, foi considerado o parâmetro de Fontes e Neri (2019), com a questão: “de modo geral como o(a) senhor(a) avalia sua saúde agora?”. As respostas contemplavam as alternativas “muito ruim/ruim”, “regular”, “boa/muito boa”.

A Escala de Resiliência foi adaptada para a cultura brasileira por Pesce *et al.* (2005). Esta escala contém 25 questões agregadas em três fatores. O fator 1 indica “resolução de ações e valores” que dão sentido à vida. O fator 2 agrupa itens que transmitem a ideia de independência e determinação e o fator 3 indica autoconfiança e capacidade de adaptação a situações (*ibidem*). A escala de resiliência tem como objetivo identificar o comportamento psicossocial para superação de cada idoso em eventos relevantes da vida ou capacidade do indivíduo de recuperar-se do estresse (Gurgel *et al.*, 2013). Um resultado abaixo dos 121 é considerado indicativo de “resiliência baixa”; um resultado entre 121 e 145 é considerado como “resiliência moderadamente baixa” a “resiliência moderada”, e acima dos 145 é considerado de “moderadamente elevada” a “resiliência elevada” (Wagnild, 2009). Admite-se, ainda, que cada item possa ser usado em contexto clínico como “pretexto” para a discussão com o sujeito. O sujeito responde consoante concorda ou não – aplicando a si próprio – com a descrição que é feita em cada um dos itens (e.g., “Sou uma pessoa determinada”, “Estou bem comigo próprio”), ou relativamente à forma como se comporta em situações que envolvam estresse (e.g., “Quando me encontro numa situação difícil, costumo sair dela”, “Sou capaz de me adaptar facilmente a situações imprevistas”). Com o objetivo de avaliar a validade concorrente da Escala de Resiliência, foi analisada a sua relação com o grau de ansiedade (enquanto traço) – dado ser

ntitativos dos entrevistados foram inseridos em um banco de dados, no JASP SP versão 0.19.3, analisados por meio de estatística descritiva (média, limite máximo, desvio-padrão – DP) e análise inferencial. Devido ao tamanho pequeno da amostra, utilizou-se o Teste de Shapiro-Wilk para analisar a normalidade (se o valor de  $p < 0,05$  indica distribuição não normal) e o Teste Exato de Fisher para determinar associação significativa entre duas variáveis categóricas (nível de resiliência com: sexo; arranjo familiar; cor da pele e autoavaliação de saúde). Empregou-se o Teste U de Mann-Whitney, não paramétrico, para comparar duas amostras independentes ( $n=20$  e distribuição não normal) (Gerald; Patson, 2021). Considerou-se, ainda, o tamanho do efeito *Rank biserial correlation*, cujos valores foram determinados por Cohen (1988) como: até 0,125 (irrisório); entre 0,125 e 0,303 (pequeno); entre 0,304 e 0,464 (moderado); maior ou igual a 0,465 (alto).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética com Seres Humanos da UEMS (Parecer nº 5.653.896). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

## RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 20 entrevistados, houve o predomínio de mulheres (85%), pessoas brancas (65%), que não moravam sozinhas (60%), aposentadas ou pensionistas (80%) e com média de idade de 68,65 anos (mínimo de 62 e máximo de 81 anos;  $DP=5,869$ ) e média de 11,45 anos de estudos (mínimo de cinco e máximo 20 anos de estudo;  $DP=3,776$ ). A maioria dos idosos autoavaliou a sua saúde como “muito boa/boa”, e a resiliência foi considerada de “moderadamente elevada” para “elevada”, com média de 157,05 (mínimo de 130,00 e máximo de 172,00;  $DP=12,237$ ). A normalidade dos resultados de idade, escolaridade e do escore total da Escala de Resiliência foram avaliados por meio do teste Shapiro-Wilk, e os resultados mostraram que a variável idade tinha distribuição normal: idade [ $S-W(20) = 0,905$ ,  $p=0,052$ ], enquanto as variáveis escolaridade [ $S-W(20)=0,897$ ,  $p=0,036$ ] e escore total de Resiliência [ $S-W(20)=0,897$ ,  $p=0,036$ ] não tinham distribuição normal.

Os resultados da associação entre variáveis categóricas e a distribuição pela Escala de Resiliência estão dispostos na Tabela 1. Não houve registro de autoavaliação de saúde como “ruim ou muito ruim”, bem como não houve autorrelato de cor de pele preta e amarela. Não houve associação significativa entre as variáveis categóricas e os níveis da Escala de Resiliência ( $p > 0,05$ ).

Segundo Silva *et al.* (2019), a resiliência é a habilidade de se adaptar e superar adversidades, sendo fundamental para a qualidade de vida dos idosos, especialmente em ambientes urbanos, onde desafios como o isolamento social e problemas de saúde são mais comuns. Os autores destacam que o envelhecimento populacional é uma realidade em muitas sociedades, e que entender como os idosos lidam com os desafios da idade avançada é importante para o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções sociais.

A predominância de mulheres (85%) entre os entrevistados é comum em estudos com idosos, pois as mulheres tendem a viver mais que os homens. Além disso, a alta taxa de solteiros (40%) e viúvos (20%) reflete um possível cenário de menor suporte conjugal, o que poderia gerar maior vulnerabilidade. No entanto, a maioria desses idosos (60%) mora acompanhada, o que pode indicar uma fonte importante de suporte social, fundamental

**Associação entre variáveis categóricas e a distribuição pela Escala de Resiliência em idosos, MS, 2023.**

| CARACTERIZAÇÃO                     | ESCALA DE RESILIÊNCIA |           | Valor de p<br>(Fisher's) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
|                                    | Moderada*             | Elevada** |                          |
| <b>Sexo</b>                        |                       |           |                          |
| Masculino                          | 1                     | 2         | 0,509                    |
| Feminino                           | 3                     | 14        |                          |
| <b>Cor da pele</b>                 |                       |           |                          |
| Branca                             | 1                     | 12        | 0,101                    |
| Parda                              | 3                     | 4         |                          |
| <b>Arranjo familiar</b>            |                       |           |                          |
| Mora sozinho                       | 1                     | 7         | 0,619                    |
| Mora acompanhado                   | 3                     | 9         |                          |
| <b>Ocupação atual</b>              |                       |           |                          |
| Inativo (Aposentados/Pensionistas) | 4                     | 12        | 0,538                    |
| Ativo (Trabalha)                   | --                    | 4         |                          |
| <b>Autoavaliação de saúde</b>      |                       |           |                          |
| Muito boa/Boa                      | 3                     | 12        | 1,000                    |
| Regular                            | 1                     | 4         |                          |
| <b>TOTAL</b>                       | 4                     | 16        |                          |

**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025.

Legenda: \*: “resiliência moderadamente baixa” a “resiliência moderada”; \*\*: “resiliência moderadamente elevada” a “resiliência elevada”.

Outro ponto relevante é o fato de que 80% dos idosos entrevistados são inativos (aposentados ou pensionistas), uma condição que pode estar associada a desafios, como a perda de identidade profissional e a redução da interação social. No entanto, Silva *et al.* (2019) salientam que a participação em atividades comunitárias, como a Universidade Aberta da Melhor Idade, pode compensar esses fatores, proporcionando oportunidades de interação social e engajamento, o que contribui para aumentar a resiliência.

As redes sociais de apoio, sejam familiares ou comunitárias, desempenham um papel central na promoção do bem-estar psicológico e físico dos idosos. Esses suportes são fundamentais para mitigar sentimentos de solidão e isolamento, condições que afetam muitos idosos, sobretudo em áreas urbanas. Esse tipo de suporte social contribui não apenas para a saúde física, mas também para a resiliência emocional, oferecendo aos idosos um senso de pertencimento e recursos práticos para enfrentar desafios (Silva *et al.*, 2019). A literatura aponta que idosos com maior suporte social tendem a relatar melhores condições de saúde e a manter um estado emocional mais equilibrado (Fortes; Portuguese; Argimon, 2009).

A relação entre resiliência e arranjo familiar também se destaca, especialmente ao observar que 40% dos idosos do estudo vivem sozinhos. Embora essa condição possa acarretar uma aparente vulnerabilidade, os elevados níveis de resiliência relatados por esses indivíduos

a capacidade de adaptação dos idosos resilientes que, mesmo em situações de isolamento, conseguem manter o equilíbrio emocional e cognitivo. A resiliência dos idosos enfrente as adversidades da velhice com autonomia e otimismo, demonstrando que o suporte social não precisa ser exclusivamente diário e presencial para ser eficaz.

A autoavaliação de saúde percebida por 75% dos participantes como “muito boa/boa” está em consonância com os achados do estudo de Fontes e Nery (2019), onde a avaliação positiva de saúde e satisfação com a vida foram associadas com estratégias de desenvolvimento caracterizadas pela superação das adversidades de uma forma positiva, delas derivando aprendizagem e contribuindo para o bem-estar geral e, por conseguinte, para a resiliência. O estudo de Fortes, Portuguese e Argimon (2009) sugere que uma boa percepção de saúde está correlacionada com maiores índices de resiliência, uma vez que idosos que se percebem saudáveis tendem a enfrentar melhor as adversidades e a preservar suas funções cognitivas.

Os resultados da Tabela 1 demonstram que a maioria dos idosos apresenta uma resiliência elevada, o que reforça a importância do suporte social mencionado por Silva *et al.* (2019) e Silva Júnior e Eulálio (2022). A participação em atividades educacionais e sociais, como as oferecidas pela Universidade Aberta, pode ser vista como uma estratégia de suporte social formal que fortalece a capacidade de adaptação e enfrentamento, apoiando esses idosos a se manterem resilientes diante dos desafios da vida urbana e do envelhecimento.

Embora a análise inferencial, por meio do Teste de Mann-Whitney (Tabela 2) não tenha demonstrado diferenças significativas nos níveis de resiliência entre os grupos de idosos considerando sexo, cor da pele, arranjo familiar e autoavaliação de saúde ( $p > 0,05$ ), tais achados, embora não permitam generalizações devido ao tamanho da amostra, oferecem insights importantes sobre a dinâmica da resiliência no contexto específico da UNAMI.

A ausência de diferenças significativas pode sugerir uma certa homogeneidade nos níveis de resiliência entre os participantes, possivelmente influenciada pelo ambiente de suporte social e engajamento proporcionado pela Universidade Aberta.

Os achados deste estudo com idosos da UNAMI, em Dourados, encontram eco na pesquisa de Silva Júnior e Eulálio (2024), com uma amostra maior de idosos da Atenção Básica, que também não identificou diferenças significativas na resiliência em relação ao sexo e arranjo familiar, embora tenha encontrado um índice elevado de resiliência. A similaridade nesses resultados, apesar das diferenças no contexto da coleta de dados (espaço de convivência social versus unidades de saúde), pode indicar que determinados fatores, como o engajamento em atividades sociais e comunitárias, desempenham um papel crucial na manutenção da resiliência em idosos, independentemente do seu arranjo familiar ou da percepção inicial de saúde. Na amostra da UNAMI, a predominância de mulheres com alta resiliência pode refletir sua maior adesão e participação nas atividades educativas, sociais e culturais oferecidas, o que, por sua vez, fortalece seus recursos resilientes, atenuando possíveis diferenças que poderiam surgir em outros contextos. A coesão social e o senso de pertencimento promovidos pela UNAMI podem, portanto, ser fatores importantes na equalização dos níveis de resiliência entre os participantes, independentemente de outras variáveis sociodemográficas ou de saúde.

|                        | n  | U      | p     | $r_{rb}$  | MÉDIA   | DP     | MÉDIA RANK |
|------------------------|----|--------|-------|-----------|---------|--------|------------|
|                        |    | 26,000 | 1,000 | 0,020***  |         |        |            |
| Feminino               | 17 |        |       |           | 157,647 | 11,494 | 10,529     |
| Masculino              | 3  |        |       |           | 153,667 | 18,583 | 10,333     |
| Arranjo familiar       |    | 35,500 | 0,353 | -0,260**  |         |        |            |
| Acompanhado            | 12 |        |       |           | 154,417 | 13,767 | 9,458      |
| Sozinho                | 8  |        |       |           | 161,00  | 8,880  | 12,063     |
| Autoavaliação de saúde |    | 33,000 | 0,726 | -0,120*** |         |        |            |
| Muito boa/boa          | 15 |        |       |           | 156,733 | 12,646 | 10,200     |
| Regular                | 5  |        |       |           | 158,000 | 12,247 | 11,400     |
| Cor da pele            |    | 58,000 | 0,340 | 0,275**   |         |        |            |
| Branca                 | 13 |        |       |           | 160,538 | 7,423  | 11,462     |
| Parda                  | 7  |        |       |           | 150,571 | 16,989 | 8,714      |

**Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.**

Legenda: n (tamanho da amostra); U (U Mann-Whitney Test); p (valor de p);  $r_{rb}$  (Ranking Biserial Correlation - \*\* tamanho de efeito pequeno; \*\*\* tamanho de efeito irrisório); DP (desvio-padrão).

Análise de Rodrigues e Tavares (2021), estudando idosos de Uberaba, Minas Gerais (MG), identificou que a resiliência se associou significativamente ao sexo masculino, autopercepção positiva de saúde e arranjo familiar (residir acompanhado). Os valores elevados de resiliência indicam as potencialidades dos idosos quanto à competência pessoal, confiança em si mesmo, aceitação positiva de mudanças e relações seguras.

Trica *et al.* (2024) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise de 21 estudos, e examinaram a correlação entre o envelhecimento bem-sucedido e os níveis de resiliência psicológica em uma população com idade igual ou superior a 60 anos. Os resultados evidenciaram um efeito de magnitude média, indicando uma associação positiva estatisticamente significativa entre os constructos de resiliência e envelhecimento bem-sucedido. Salientaram a inter-relação intrínseca entre as percepções e atitudes dos idosos referentes ao processo de envelhecimento, suas avaliações subjetivas e os índices de resiliência psicológica por eles apresentados. O estudo constatou, ainda, que a resiliência opera como um mecanismo protetor contra adversidades de natureza psicológica e física, o que ressalta a relevância da implementação de estratégias destinadas ao fortalecimento da capacidade resiliente em intervenções cujo propósito seja a promoção do envelhecimento bem-sucedido. Os achados desta revisão confirmaram a relevância das atividades educativas, sociais e culturais desenvolvidas pela UNAMI, destacando que a resiliência deve ser vista como uma construção dinâmica, não apenas um traço de personalidade estável. Essa visão sugere que os recursos de resiliência em idosos podem ser aprimorados por meio de programas interventivos focados no bem-estar e nas capacidades funcionais, incluindo habilidades cognitivas.

Os resultados desta pesquisa em Dourados apontaram uma resiliência elevada na amostra estudada. Para refinar essa compreensão, a análise das respostas individuais às questões da Escala de Resiliência revelou nuances importantes sobre os recursos e possíveis desafios enfrentados por esses idosos. Destaca-se que três questões da Escala de Resiliências obtiveram médias acima de 6,8. As questões 6 (“Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha

raramente penso sobre o objetivo das coisas”) com média 4,40 (DP 2,062), a isas um dia de cada vez”) com média 5,50 (DP 2,039) e a 20 (“Às vezes eu me isas querendo ou não”) com média 5,45 (DP 1,932).

As três questões com as maiores médias, relacionadas ao orgulho das realizações (questão 6), à amizade consigo mesmo (questão 8) e ao sentido de vida (questão 21), refletem recursos pessoais importantes para a resiliência. Conforme Silva Júnior; Eulálio (2022), o orgulho das conquistas e o sentido de propósito estão intimamente ligados à autoestima e à capacidade de manter uma perspectiva positiva sobre a vida. Esses fatores são centrais na resiliência pessoal, permitindo que o idoso enfrente adversidades com maior confiança e otimismo, algo fundamental para um envelhecimento saudável.

Por outro lado, as questões que obtiveram as menores médias – refletindo a dificuldade de pensar no objetivo das coisas (questão 11), a abordagem de viver um dia de cada vez (questão 12) e a imposição de realizar tarefas mesmo sem vontade (questão 20) – indicam possíveis barreiras na resiliência. Esses aspectos sugerem uma dificuldade em encontrar propósito e significado em atividades diárias, o que pode comprometer o bem-estar emocional e o enfrentamento de desafios. Isso pode estar relacionado à falta de apoio social ou de atividades significativas, temas discutidos por Silva *et al.* (2019) e Silva Júnior e Eulálio (2022), como fatores que fortalecem a resiliência na velhice.

A baixa pontuação em questões que envolvem o sentido de objetivo (questão 11) e a imposição de fazer tarefas (questão 20) também pode sugerir uma ausência de engajamento em atividades que tragam satisfação e propósito. Idosos que não conseguem manter atividades que consideram significativas podem sentir-se desmotivados, o que tende a afetar negativamente sua capacidade de resiliência.

A importância dos mecanismos sociais e dos recursos pessoais – como a sensação de realização, a autoestima e o senso de propósito – são essenciais para a resiliência, enquanto a falta de significado e o desafio de encontrar propósito nas atividades diárias indicam áreas onde o suporte social e as intervenções podem ser necessários para fortalecer a resiliência e promover um envelhecimento bem-sucedido (Silva *et al.*, 2019; Silva Júnior; Eulálio, 2022).

A discussão sobre os fatores que contribuem para a resiliência elevada observada, como suporte social e recursos internos, ganha uma nova camada de complexidade ao considerar o conceito de ageísmo, ou seja, a discriminação baseada na idade. A relação entre os dados discutidos anteriormente e os achados do estudo de Manso, Mello e Lopes (2024) sobre ageísmo e sua inter-relação com resiliência e capacidade funcional em idosos, ressaltam o impacto de fatores psicossociais no envelhecimento. Neste estudo, Manso, Mello e Lopes (2024) examinam como o ageísmo – ou seja, a discriminação baseada na idade – afeta a capacidade funcional e a resiliência dos idosos. Os resultados revelaram que as pessoas que experimentam menos preconceito etário tendem a ter maior resiliência e capacidade funcional preservada. O estudo concluiu que o ageísmo é um fenômeno sociocultural que afeta idosos, cuidadores, familiares e profissionais de saúde. Manifesta-se por meio de concepções negativas sobre o declínio fisiológico, a infantilização e a patologização do envelhecimento.

A conexão com redes sociais de apoio, sejam familiares ou comunitárias, emerge como um fator-chave para promover o bem-estar psicológico e físico dos idosos, mitigando a sensação de solidão e isolamento, problemas que se intensificam em grandes centros urbanos (Silva *et al.*, 2019). Este suporte social também se configura como uma forma de proteção contra os

vada em grande parte dos participantes do estudo de Silva *et al.* (2019), sugere estão conseguindo manter o equilíbrio emocional e a funcionalidade, mesmo afios, o que é reforçado pela preservação de redes de apoio que os ajudam a enfrentar esses obstáculos.

Além disso, os dados que mostram altos níveis de resiliência entre idosos que moram sozinhos (40%) indicam a capacidade de ativar recursos internos para lidar com a vulnerabilidade. Este achado também está em consonância com as descobertas de Manso, Mello e Lopes (2024), que sugerem que a resiliência pode atuar como um mediador entre a exposição ao ageísmo e a preservação da capacidade funcional. Tais ideias generalizadas impõem uma visão homogênea dos idosos, ignorando sua diversidade e individualidade. As representações sociais sobre o envelhecimento, construídas e disseminadas culturalmente, contêm visões negativas e estigmatizantes que contribuem para que os idosos sejam marginalizados na sociedade e para que a violência contra eles seja vista como algo natural (Manso; Mello; Lopes, 2024).

A UNAMI desenvolve atividades educativas que abordam os direitos das pessoas idosas, cidadania e envelhecimento ativo, além de promover iniciativas culturais, esportivas e de lazer. Estas ações visam integrar os idosos ao ambiente acadêmico, fomentando interações intergeracionais que permitem aos jovens reconhecerem as potencialidades e o capital socio-cultural dos idosos, respeitando suas histórias de vida.

Conforme Medeiros *et al.* (2020), o projeto transcende o ensino regular da graduação ao possibilitar uma efetiva integração entre gerações, restabelecendo o protagonismo dos idosos participantes e evidenciando suas contribuições sociais. Este processo não apenas resgata a autoestima dos participantes, mas também reafirma sua condição de cidadania plena.

Assim, idosos resilientes são mais capazes de enfrentar os estigmas sociais e manter sua autonomia, mesmo quando expostos a discriminações e preconceitos relacionados à idade.

### *Limitações do estudo*

Como limitações, destaca-se o tamanho reduzido da amostra pesquisada, a qual foi constituída por 20 pessoas que participavam das atividades há mais de um ano e estiveram presentes nos dias da coleta de dados. Este quantitativo impactou na avaliação dos testes estatísticos que não permitiu analisar diferenças significativas e nem tamanhos de efeitos elevados.

Outro possível viés foi avaliar a resiliência com pessoas que frequentavam a UNAMI. Tal fato pode ter influenciado nas altas médias dos escores das respostas, pois são pessoas que prezam pela autonomia, participação em atividades sociais e culturais.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa com idosos frequentadores da UNAMI mostrou elevados níveis de resiliência nessa população. O achado sugere que programas como universidades abertas são estratégias promissoras para fortalecer a capacidade de idosos enfrentarem os desafios

ia do suporte social, evidenciada pela alta resiliência em idosos que moram participam ativamente da UNAMI, aponta para a necessidade de políticas s redes de apoio existentes e criem oportunidades de interação social para a terceira idade, como centros de convivência e programas intergeracionais.

As menores pontuações em questões sobre o sentido de objetivo e a imposição de tarefas indicam áreas para intervenção. Políticas públicas e programas de apoio devem priorizar atividades que promovam o engajamento, o senso de propósito e a autonomia dos idosos, como oficinas e programas de voluntariado.

A urgência de combater o ageísmo, que impacta negativamente a resiliência, reforça a necessidade de implementação de políticas, campanhas de conscientização e legislação anti-discriminatória que promovam uma visão positiva do envelhecimento.

Em suma, os resultados da pesquisa da UNAMI destacam o potencial de programas de engajamento social e aprendizado contínuo, a importância do suporte social e a necessidade de combater o ageísmo como elementos cruciais a serem considerados no desenvolvimento de políticas públicas eficazes para promover a resiliência e o envelhecimento bem-sucedido.

## Referências

COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, 1988.

MASTEN, A. S.; GEWIRTZ, A. H. Vulnerability and resilience in early child development. *In*: MCCARTNEY, K.; PHILLIPS, D. (ed.). **Blackwell handbook of early childhood development**. Malden: Blackwell Publishing, 2008. p. 22-41.

SELIGMAN, M. E. P. **Florescer**: uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

SOUZA, J. C.; PINTO, F. R.; ARAÚJO, A. P. **Síndrome de Bournout e resiliência humana na atividade docente superior**: existe correlação significativa entre esses dois construtos? Londres: Novas Edições Acadêmicas, 2017.

Fonte de financiamento

## os autores

Lusmara Santos Coffacci - elaboração do texto, coleta dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Paulo Ramsés da Costa - elaboração do texto, análise dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Ana Beatriz Aparecida Fernandes Dantas - elaboração do texto, coleta dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Elaine Aparecida Mye Takamatu Watanabe - elaboração do texto, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

Marcia Regina Martins Alvarenga - concepção e planejamento do estudo, elaboração do texto, coleta e análise dos dados, revisão do conteúdo, aprovação da versão final do manuscrito e responsabilidade pública pelo conteúdo do artigo.

## Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

## Responsabilidade editorial

Ramona Fernanda Ceriotti Toassi, Rafael Arenhaldt, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil

Recebido em: 28/02/2025

Aceito em: 12/05/2025

Publicado em: 17/05/2025